

TRANSKRIP LENGKAP WAWANCARA & OBSERVASI LAPANGAN

Studi Alur Pendaftaran Pasien, Pengelolaan Rekam Medis (RME), Integrasi SATUSEHAT, & Rencana Sistem QR Code / OCR

Nama Peneliti	:	Faradilla Anastasia Putri	Institusi	:	Politeknik Negeri Jember (Polije)
Program Studi	:	D4 Manajemen Informasi Kesehatan (MIK)	Fokus Penelitian	:	Sistem Pendaftaran Online & Integrasi RM
Narasumber 1	:	Mbak Sania (Staf Rekam Medis)	Narasumber 2	:	Mas IT (Staf SIMRS / Teknologi Informasi)
Narasumber 3	:	Petugas Loker Pendaftaran / Front Office	Metode	:	Wawancara Semi-Terstruktur & Observasi Sistem Langsung

I. RINGKASAN EKSEKUTIF & TEMUAN TEKNIS

Poin-Poin Utama Hasil Observasi & Diskusi:

- Alur Data Pasien & Sensus:** Registrasi mencakup identitas KTP/KK, pemisahan wilayah (dalam/luar kota untuk laporan Kemenkes), dan keluhan utama. Sensus harian menghubungkan loket pendaftaran, perawat poli, dan unit rekam medis dalam satu alur terpusat.
- Validasi NIK, Pasien Bayi, & Pasien Khusus:** Sistem SIMRS memvalidasi NIK secara otomatis guna mencegah duplikasi nomor RM (*warning* otomatis jika NIK telah terdaftar). Pasien bayi baru lahir menggunakan NIK Ibu sementara hingga memiliki NIK mandiri. Kasus tanpa identitas difasilitasi dengan opsi formulir identitas tidak lengkap dan verifikasi susulan melalui WhatsApp.
- Hak Akses & Kewenangan Data:** Petugas pendaftaran memiliki akses input awal, sedangkan perbaikan (*editing*) data demografi dan nomor rekam medis lanjutan menjadi wewenang khusus unit Rekam Medis. Perubahan data di loket hanya dapat dilakukan sebelum proses pelayanan klinis/CPPT diisi oleh perawat poli.
- Integrasi SATUSEHAT & DICOM/PACS:** Integrasi SATUSEHAT untuk data Rawat Jalan telah berjalan 100% (13 *resources* data Kemenkes terpenuhi secara bertahap). Layanan Radiologi memiliki kendala pengiriman file DICOM karena belum tersedianya modul PACS untuk menghasilkan *Accession Number* unik, yang saat ini diatasi dengan bantuan vendor dan injeksi kode unik.
- Rencana Inovasi Pendaftaran QR Code & OCR:** Diskusi teknis menyepakati bahwa sistem pendaftaran online berbasis QR Code dapat dioptimalkan tanpa harus *bridging* penuh ke vendor pihak ketiga, yaitu menggunakan kombinasi OCR dan API AI untuk membaca teks dari gambar/dokumen dan secara otomatis mengisi *field* formulir pendaftaran, meniru keberhasilan modul cetak label RM otomatis.

II. TRANSKRIP DIALOG WAWANCARA & OBSERVASI SISTEM

Mbak Sania **Rekam Medis**

Entar dulu ya Mbak... Nanti foto bilang lho ya, aku nggak pakai kerudung.

Faradilla **Peneliti MIK**

Iya, nanti aja fotonya. Ini kayaknya bakalan ngulang-ngulang pertanyaan yang sama kayak kemarin, cuma ini ingin lebih tersusun dan terstruktur.

Mbak Sania **Rekam Medis**

Iya, lebih tersusun dan terstruktur. Oke. Kalau kemarin kan masih pendahuluan nih.

Faradilla **Peneliti MIK**

Kalau dari Mbak Sania sendiri, alur pengolahan datanya, pencatatan rekam medisnya itu butuh apa aja Mbak?

Mbak Sania **Rekam Medis**

Berarti tahapnya nanti ke pelaporan nih dari data pendaftaran. Butuhnya sesuai di sensus sih kebutuhannya. Sek-sek, aku juga tak pastikan apa aja. Yang jelas nanti itu ditanyain dulu kan pasien lama/barunya. Terus data identitas dasar: nama, alamat, KTP sesuai KTP. Di pendaftaran pasti ada keluhan sama nomor HP. Rujukan kita semuanya full ke sensus. Soalnya nanti data olahnya ya ke sini.

Mbak Sania **Rekam Medis**

Ini bagian pendaftaran nih: yang dari depan dulu yang ngisi: tanggal pendaftaran, nomor urut pasien datang daftar, status kunjungan (lama/baru), alamat (kita bedain dia dari dalam kota apa luar kota, soalnya di pelaporan Kemenkes itu ada laporan kunjungan dalam kota dan luar kota, laki-laki dan perempuan), nomor HP, terus keluhannya apa. Terus kalau sudah ke perawat, baru ditanyain kasusnya.

Faradilla **Peneliti MIK**

Berarti dari pendaftaran identitasnya, nanti langsung ke poli?

Mbak Sania **Rekam Medis**

Poli, iya. Prinsipnya udah jadi satu. Jadi satu file ini yang ngisi tiga bagian: pendaftaran, nanti kasus/diagnosa/tindakan dan jenis pelayanan itu poli. Kalau laporan anak ada jenis pelayanan neonatal dan anak, kalau kandungan ada obstetri dan ginekologi. Itu yang ngisi di poli perawat, karena cuma butuh data.

Mbak Sania **Rekam Medis**

Karena sudah nginput di sistem di pendaftaran, biasanya sudah ada di aplikasinya. Aku tinggal copy-paste aja sih, biar bagian depan nggak terlalu banyak isinya kayak tanggal lahir, cara bayar, umur. Umur bisa otomatis pakai rumus dari tanggal kunjungan dan tanggal lahir. Form identitas pasien semuanya wajib diisi, apalagi anak-anak atau lansia ada penanggung jawabnya.

Faradilla **Peneliti MIK**

Kalau misal ada masalah identitas nggak lengkap, bagaimana penanganannya Mbak?

Mbak Sania **Rekam Medis**

Misal NIK nggak bawa atau tanggal lahir nggak sesuai, kita kasih note di depan map bahwa identitas belum lengkap. Ketika pasien pulang tetap dihubungi lewat WhatsApp minta identitasnya dikirim. Kalau mentok nggak ada balasan, tetap di-note identitas tidak lengkap.

Faradilla **Peneliti MIK**

Bagaimana cara mendeteksi atau menangani pasien dengan nomor rekam medis ganda?

Mbak Sania **Rekam Medis**

Secara sistem sudah ada warning: nomor NIK ini sudah terdaftar. Kalau dia by NIK, langsung otomatis keluar notifikasinya. Makanya patokan utama kita di NIK. Kalau bayi baru lahir kan belum punya NIK, di sistem ada opsi isi NIK pasien atau NIK ibu. Jadi NIK ibunya yang diisi di bagian bawah.

Faradilla **Peneliti MIK**

Siapa yang berwenang memperbarui data pasien jika ada kesalahan?

Mbak Sania **Rekam Medis**

Di Rekam Medis yang berwenang. Akun pendaftaran nggak bisa ganti kalau sudah selesai, harus lapor dulu ke RM. Tapi kalau proses pelayanan di poli belum selesai dan CPPT belum diisi oleh perawat, bagian pendaftaran masih bisa mengeditnya.

Mas IT **SIMRS / IT**

Iya, selama CPPT-nya belum diisi dengan perawat itu bisa dirubah di pendaftaran. Bisa digunakan orang lain untuk nomor RM tersebut. Kecuali CPPT sudah terisi, itu tidak bisa dihapus.

Faradilla **Peneliti MIK**

Apakah SOP di sini sudah menerapkan Rekam Medis Elektronik (RME)?

Mas IT **SIMRS / IT**

Secara SOP sebenarnya kita sudah RME, cuma untuk implementasi kita masih less paper, jadi belum full 100% paperless karena masih ada penggunaan formulir kertas tertentu.

Faradilla **Peneliti MIK**

Apakah sistem rumah sakit saat ini sudah terintegrasi dengan SATUSEHAT?

Mas IT **SIMRS / IT**

Sudah. Integrasi data SATUSEHAT untuk rawat jalan sudah 100% terpenuhi untuk 13 resource data wajib Kemenkes. Kendalanya terakhir ada di radiologi karena wajib menggunakan PACS untuk file DICOM. Kita punya file DICOM tapi belum punya PACS untuk menghasilkan Accession Number (kode unik data terbaca di SATUSEHAT). Saat ini diatasi dengan inject accession number mandiri dibantu vendor.

Mas IT **SIMRS / IT**

Pengiriman data ke SATUSEHAT dilakukan secara manual cross-check oleh tim Rekam Medis setelah pelayanan selesai dan diagnosa ICD diberi kode, tidak dibuat otomatis penuh agar tetap ada proses filtering kelengkapan dan kebenaran kode.

Faradilla **Peneliti MIK**

Perkenalkan saya Faradilla Anastasia Putri dari Politeknik Negeri Jember, Jurusan Manajemen Informasi Kesehatan. Tujuan penelitian tugas akhir/skripsi saya adalah merancang sistem pendaftaran online berbasis QR Code yang terintegrasi dengan data SATUSEHAT untuk rawat jalan agar petugas loket tidak perlu mengetik ulang data pasien.

Mas IT **SIMRS / IT**

Saran saya, daripada kesulitan bridging langsung ke sistem vendor utama yang aksesnya terbatas, kalian bisa memanfaatkan kombinasi OCR dan API AI. Dari QR Code atau screenshot KTP, sistem mengekstrak teks via OCR lalu dirapikan AI untuk otomatis mengisi field pendaftaran tanpa mengetik ulang. Konsep ini persis seperti modul cetak label otomatis Rekam Medis yang kami kembangkan di sini.

Petugas Loker **Pendaftaran**

Kalau pasien baru daftar online lewat WhatsApp, mereka bawa KK/KTP saat datang. Masalah yang sering terjadi itu salah ketik jenis kelamin atau typo alamat. Alamat kita gunakan alamat domisili sekarang jika beda dengan KTP.

Petugas Loker **Pendaftaran**

Di sini diberlakukan sistem kuota per poli dokter (sekitar 25-30 pasien per hari, paling ramai Selasa dan Kamis). Pasien rawat jalan membayar deposit awal Rp200.000, nanti saat pelunasan tagihan akhir akan dikembalikan jika ada sisa, atau membayar kekurangannya jika ada tindakan/obat tambahan.

Mas IT SIMRS / IT

Ayo kita lihat langsung di layar pendaftaran depan untuk demonstrasi penginputan pasien baru, pasien bayi dengan NIK ibu, opsi pasien tanpa identitas, dan cara kerja aplikasi pembacaan data label otomatis.